

FUNCTIONAL SPECIFICATION DOCUMENT (FSD)

Modul: Cashier Receipt Form (CRF) & Rekonsiliasi Kasir

Nomor Dokumen: FSD-MEDIKA-CRF-001 | Tiket: CRF-201

Author: Danang Prasetyo (Product Lead) | Tanggal: 10 Agustus 2025

Target: Sprint 24 - Core Billing & Cashier Microservices

1. LATAR BELAKANG & OBJECTIVE

Setiap kasir klinik yang masuk shift kerja wajib buka dan tutup kasir pakai Cashier Receipt Form (CRF). CRF berfungsi sebagai kontrol internal agar kas tidak tekor dan rekonsiliasi pembayaran fisik vs sistem klop. Sistem otomatis mengkalkulasi dan merekonsiliasi pembayaran tunai (cash) maupun non-tunai.

2. BUSINESS RULES & INITIAL REQUIREMENTS

2.1 Buka Shift & CRF Owner Restriction

- Kasir wajib input nominal Initial Deposit (modal awal kembalian) saat membuka shift.
- Isolasi akses: Hanya kasir pemilik yang boleh ubah data dan close CRF miliknya (Owner Restriction).

2.2 Pencatatan Transaksi Multi-Channel

- Support payment method: Cash, QRIS, Kartu Debit, Kartu Kredit, Xendit, dan Voucher klinik.
- Sistem otomatis menghitung total akumulasi penerimaan per payment method ke summary CRF.

2.3 Tutup Shift & Alur Koreksi Invoice Pasca EOD Closing

- Kasir melakukan closing CRF di akhir shift, dilanjutkan proses EOD Closing harian klinik.
- Koreksi invoice setelah EOD closing dapat diajukan kasir maksimal 7 hari kalender (Correction Window).
- Pengajuan koreksi invoice wajib di-approve oleh Finance Supervisor.
- Jika di-approve, invoice dan CRF beralih status ke Under Revision untuk rekonsiliasi ulang kasir.

3. ACCEPTANCE CRITERIA

AC-1: Validasi initial deposit wajib diisi dan bernilai positif sebelum shift dibuka.

AC-2: Percobaan akses edit/tutup CRF oleh kasir lain di-reject dengan error 403 Forbidden.

AC-3: Pengajuan koreksi invoice lewat dari 7 hari kalender di-reject sistem secara otomatis.

AC-4: Invoice dan CRF berstatus Under Revision sebelum kasir menyelesaikan verifikasi re-close.